

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Varicocoele (Laparoscopic Division of Testicular Veins)

معلومات الإقرار – نسخة المريض دوالي الخصية (تقسيم أوردة الخصية بالمنظار)

1. What do I need to know about this procedure?

This is a cut and clip of the varicose veins to the scrotum laparoscopically i.e. with the help of a video camera through tubes in very small cuts in the abdomen. Tubes will be put through these cuts to pass the camera and instruments through. The doctor will fill the abdominal area with carbon dioxide gas to allow access for the operation. The gas is allowed to escape before the cuts are closed with stitches or staples.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

يشتمل هذا الإجراء على قطع ثم تثبيت الأوردة المتوسعة على الخصية باستخدام المنظار (بمساعدة كاميرا فيديو يتم تمريرها عبر أنابيب من خلال شقوق جراحية صغيرة في البطن). يتم إدخال أنابيب عبر هذه الشقوق الصغيرة لإدخال الكاميرا والأدوات الجراحية. يقوم الطبيب بملي منطقة البطن بغاز ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى موضع الجراحة. يتم تفريغ البطن من الغاز في نهاية العملية قبل إغلاق الجروح الصغيرة بالخيوط أو الدبابيس الجراحية.

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ **تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك** للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- لدى أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

strain on the heart.

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific Risks:

- Damage to large blood vessels, gut or bladder may occur when the surgeon has inserted a sharp trocar and cannula at the start of the operation, to provide access and gas insufflation.
- Rarely the gas which is fed into the abdominal cavity can cause cardiac and respiratory complications.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- Damage can occur to the blood supply of the testicle with possible damage to the testicle. As a result the testicle may shrink and lose function.
- A weakness can occur in the wound with the development of a rupture. This may need further surgery.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and the scar may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.

Notes to talk to my doctor about:

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء بالتحديد:

- ضرر قد يصيب الأوعية الدموية الكبيرة ، الأمعاء أو المثانة البولية عند إدخال الجراح للمعدات الحادة المستخدمة (المبزل والقنية) إلى البطن في بداية الإجراء لإيجاد مدخل يتم من خلاله نفخ البطن بالغاز.
- من النادر أن يسبب الغاز الذي يتم ضخه في التجويف البطني مضاعفات للقلب أو الرئة.
- قد يحدث نزيف عميق في التجويف البطني وقد يتطلب تعويض الدم المفقود بالمحاليل الطبية أو جراحة أخرى.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً.
- قد يحدث ضرر للتدفق الدموي للخصية مع احتمال تضرر الخصية . قد ينتج عن ذلك انكماش الخصية وفقدانها لوظائفها.
- قد يصبح الجرح ضعيفاً ثم يتمزق . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- عند بعض المرضى يكون التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي وقد يكون مؤلماً.
- الالتصاقات قد تتكون وقد تسبب بإسداد في الأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد بعد الجراحة ، وقد تكون هناك حاجة لعملية أخرى.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
